Planificar en promoción de la salud: por qué y cómo

SESIÓN 1 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

Propuesta docente en revisión: 31/10/2026. Pendiente de validación institucional.

Una sesión práctica: justificar la necesidad de planificar con el caso Zagra y ensayar sus fundamentos, técnicas y herramientas, desde el diagnóstico hasta la actuación.

Qué aprenderemos

- Argumentar por qué la promoción de la salud local necesita planificación, a partir de lo que ocurrió en un proceso real.
- Situar cada documento y cada decisión en su etapa del ciclo de planificación local.
- Distinguir hechos, inferencias, hipótesis y decisiones, y leer necesidades y activos con su fuente y su fecha.
- Aplicar una técnica de priorización y documentar la deliberación, incluidas las necesidades que no se priorizan.
- Pasar de una prioridad a objetivos y actuaciones con responsable, distinguiendo lo municipal de lo que corresponde al sistema sanitario.

Agenda

09:00–09:30
Práctica 1 · Zagra 2017-2026: ¿qué se perdió entre un ciclo y otro? Cuestionario inicial

09:30–10:15
Práctica 2 · Ordenar el expediente: el ciclo de planificación y la regla de no mezclar etapas

10:15–11:00
Práctica 3 · Qué sabemos y cómo lo sabemos: estatuto de la información, necesidades y activos

11:00–11:30
Descanso

11:30–12:45
Práctica 4 · Priorizar: Hanlon y deliberación de un Grupo Motor simulado

12:45–13:40
Práctica 5 · De la prioridad a la actuación: reescribir las propuestas de 2017

13:40–14:00
Herramientas del curso y presentación de las actividades virtuales V1

Práctica 1 · Zagra 2017-2026: ¿qué se perdió? (30 minutos)

Para qué: justificar la necesidad de planificar con un caso, no con una declaración. En grupos, leer la trayectoria del caso Zagra (adhesión en 2016, Grupo Motor y 18 problemas en 2017, Perfil en 2018, escrito de 2020 y nueva consulta en 2026) y responder:

Planificar en promoción de la salud: por qué y cómo

SESIÓN 1 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

- ¿Qué existía en 2017 que podría haber sostenido un plan?
- ¿Qué no consta en el expediente y habría hecho falta para que el trabajo de 2017 continuara (plan aprobado, responsables, calendario, indicadores)?
- ¿Qué tiene que reconstruir ahora el proceso de 2026 porque no quedó registrado?
- Puesta en común: cada grupo formula en una frase para qué sirve planificar en Zagra. El profesorado recoge las frases y las retoma al final de S2.

Fundamento · El ciclo de planificación local

Diagnóstico
Producto: Información organizada y con procedencia · Lo que aún no debe aparecer: Interpretaciones, prioridades u objetivos

Perfil de salud local
Producto: Lectura interpretativa y trazable de la evidencia · Lo que aún no debe aparecer: Qué se hará, quién y con qué recursos

Planificación
Producto: Plan de acción: prioridades, objetivos, actuaciones, indicadores con tiempo cero y meta · Lo que aún no debe aparecer: Resultados de la ejecución

Decisión política
Producto: Plan Local de Salud aprobado por el órgano municipal · Lo que aún no debe aparecer: Actuaciones ejecutadas como si ya fueran compromisos del plan

Ejecución
Producto: Actuaciones realizadas y datos de seguimiento · Lo que aún no debe aparecer: Juicios sobre si el plan funciona

Evaluación
Producto: Informe de evaluación, que abre el siguiente diagnóstico · Lo que aún no debe aparecer: Conclusiones de cambio sin comparación con el tiempo cero

Práctica 2 · Ordenar el expediente (45 minutos)

Situar cada elemento del expediente de Zagra en su etapa del ciclo y señalar dónde se mezclan etapas.

Informe de Salud de Zagra (2017)
Diagnóstico

Perfil de Salud Local (borrador de 2026) con cinco conclusiones
Perfil

Hoja de 18 problemas puntuados (27/04/2017)
Priorización (inicio de la planificación)

Planificar en promoción de la salud: por qué y cómo

SESIÓN 1 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

Propuestas del taller de 2017: baile, carnet de puntos, huertos
Ideas de actuación sin plan: mezclan priorización y ejecución

Consulta temática ciudadana de 2026 (158 papeletas)
Diagnóstico participativo; insumo de la priorización

Plan de Acción de cuatro bloques en COMPÁS
Borrador técnico de planificación, sin decisión

Acuerdo plenario de aprobación del Plan Local de Salud
Decisión política (no consta en el expediente)

Informe de evaluación del ciclo 2017-2018
Evaluación (no consta)

Fundamento · Por qué no mezclar etapas

- Diagnóstico con sesgo de planificación: se busca evidencia de lo que ya se ha decidido priorizar; el diagnóstico confirma en lugar de descubrir.
- Perfil que ya propone actuaciones: el equipo técnico ocupa decisiones que corresponden al Grupo Motor.
- Plan que es diagnóstico: la mayor parte del documento describe la situación y el lector no encuentra qué se va a hacer.
- Evaluación sin tiempo cero: no se registró el valor de partida y no se puede saber cuánto cambió.

Fundamento · Qué aporta cada marco

RELAS
Qué es: Metodología de proceso municipal: Grupo Motor, participación, ciclo del plan · Qué no aporta: Contenidos, prioridades o indicadores locales

EPVSA 2024-2030
Qué es: Estrategia de contenidos: 4 líneas y 10 objetivos estratégicos, con indicadores de contexto e impacto · Qué no aporta: Prioridades de cada municipio. Casi cualquier prioridad encaja en alguna línea: la alineación no valida una prioridad

ESCA 2026-2030
Qué es: Estrategia del sistema sanitario público para atención primaria. Tres niveles de orientación comunitaria: individual y familiar, grupal y colectivo · Qué no aporta: Las actuaciones de iniciativa municipal ni los recursos del Ayuntamiento

Práctica 3 · Qué sabemos y cómo lo sabemos (45 minutos)

Primera parte (25 minutos): clasificar los enunciados por su estatuto. Segunda parte (20 minutos): identificar un ejemplo de cada tipo de necesidad y relacionarlo con un activo del inventario.

Planificar en promoción de la salud: por qué y cómo

SESIÓN 1 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

Zagra tenía 843 habitantes el 1 de enero de 2025 (INE).
Hecho

El 23,5 % de la población tiene 65 años o más.
Hecho (cálculo sobre la tabla del INE)

Zagra registraba más hipertensión que el distrito: 27,56 % frente a 12,32 %.
Hecho referido a lo registrado en 2015; no prueba más frecuencia real

En Zagra hay más hipertensos que en el resto del distrito.
Inferencia no sostenida: confunde registro con prevalencia y no ajusta por edad

El bienestar emocional es la principal preocupación de la población.
Inferencia con cautela: 158 papeletas de perfil desconocido

Uno de cada tres hogares es unipersonal, luego la soledad no deseada es frecuente.
Hipótesis: vivir solo no equivale a soledad no deseada

El sedentarismo fue la primera prioridad de 2017.
Hecho sobre el orden de la hoja; su valor como priorización técnica es dudoso

El Plan de Zagra se organiza en cuatro bloques de envejecimiento saludable.
Falso como decisión: es una propuesta técnica sin acuerdo del Grupo Motor

Fundamento · Tipos de necesidad y activos

Los activos se leen con el mismo rango que los déficits: un diagnóstico no es un inventario de carencias. La participación ciudadana aporta conocimiento que la epidemiología no recoge, pero su valor depende de quién ha podido participar. Una consulta que solo recoge la voz de los grupos más activos no puede presentarse como la opinión del municipio.

Normativa
Quién la define: Criterio técnico o umbral · Ejemplo en Zagra: Exceso de riesgo de suicidio frente a España señalado por el Informe de Salud (2017)

Comparativa
Quién la define: Comparación con territorios similares · Ejemplo en Zagra: 37,0 % de la población bajo el umbral de renta, frente al 27,8 % provincial

Sentida
Quién la define: Percepción de la población · Ejemplo en Zagra: Bienestar emocional elegido en el 84,8 % de las papeletas de 2026

Expresada
Quién la define: Demanda efectiva de servicios o recursos · Ejemplo en Zagra: Uso de los talleres de socialización del complejo deportivo (dato no disponible: habría que pedirlo)

Planificar en promoción de la salud: por qué y cómo

SESIÓN 1 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

Práctica 4 · Priorizar (75 minutos)

- Lectura crítica (15 minutos): la hoja de 2017. ¿Qué escala se usó, qué significan los valores de hasta 13 y el total? ¿Puede usarse como priorización técnica?
- Puntuación (25 minutos): cada grupo puntúa entre 4 y 6 necesidades actuales de Zagra con el método Hanlon y el filtro PEARL, usando la plantilla de priorización.
- Deliberación simulada (25 minutos): un Grupo Motor con papeles asignados (concejalía, centro de salud, servicios sociales, Asociación de Mujeres, juventud y población de nacionalidad extranjera) decide entre un área integradora de envejecimiento saludable o varias áreas.
- Registro (10 minutos): acta breve con las prioridades, la motivación, cómo influyó la consulta de 2026 y qué queda fuera y por qué.

Fundamento · Criterios de priorización

Magnitud
¿A cuántas personas afecta?

Gravedad
¿Qué daño produce en la salud?

Modificabilidad
¿Existen intervenciones eficaces a nuestro alcance?

Inequidad
¿Afecta más a grupos en peor situación?

Viabilidad local
¿Tiene el municipio capacidad y aliados para actuar?

Demanda ciudadana
¿La comunidad la ha expresado? ¿Quién la ha expresado?

Técnica · Método Hanlon (versión de trabajo)

- A · Magnitud (0 a 10). B · Gravedad (0 a 10). C · Eficacia de la intervención (0 a 10).
- Puntuación básica = (A + 2B) × C / 3.
- Filtro PEARL (pertinencia, viabilidad económica, aceptabilidad, recursos, legalidad): si alguno es «no», la necesidad no se aborda en este ciclo y se documenta el motivo.
- Advertencia: el método ordena un juicio, no lo sustituye. Una diferencia de pocos puntos entre dos necesidades no justifica por sí sola la decisión.

Planificar en promoción de la salud: por qué y cómo

SESIÓN 1 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

Práctica 5 · De la prioridad a la actuación (55 minutos)

Con la prioridad elegida en la práctica 4, reescribir tres propuestas del taller de 2017 como una cadena prioridad -> objetivo general -> objetivo específico -> actuación -> actividad, con responsable (cargo) y titularidad (municipio, sistema sanitario o conjunta).

Taller de baile para parejas de adultos
Qué es: Actividad · Cadena posible: Objetivo: mejorar los contactos sociales de las personas mayores. Actuación: programa de encuentros en el complejo deportivo y la Asociación de Mujeres. Actividad: taller de baile

Carnet de puntos por participar, con sorteo
Qué es: Incentivo dentro de una actividad · Cadena posible: Objetivo: aumentar la participación de quienes no suelen participar. Hay que definir antes quiénes son y medir su participación de partida

Hacer una asociación de hombres
Qué es: Propuesta de actuación comunitaria · Cadena posible: Objetivo: aumentar la participación de los hombres en actividades comunitarias. El ayuntamiento puede apoyar, pero la decisión de asociarse es de los vecinos

Prescripción médica de rutas de senderismo
Qué es: Actuación del centro de salud · Cadena posible: Recomendación de activos (nivel individual de la ESCA), vinculada a un objetivo de actividad física y con registro en el centro de salud

Fundamento · Objetivos, actuaciones y responsables

- Objetivo general: dirección del cambio para una prioridad (uno o dos por prioridad).
- Objetivo específico: cambio concreto y medible en un plazo definido (entre dos y cinco por objetivo general).
- Un objetivo sin indicador no es verificable; sin plazo es una aspiración.
- Un objetivo no describe una tarea del equipo: «realizar talleres» es una actuación, no un objetivo.
- Actuación: unidad de intervención comprometida en el plan, con finalidad, población, responsable, calendario y recursos. Actividad: unidad concreta de ejecución dentro de una actuación.
- El responsable es un cargo identificable, no una institución.
- Para cada actuación se indica si es propia del municipio, del sistema sanitario (por ejemplo, educación para la salud grupal o mapa de activos encargados por la ESCA a la unidad de gestión clínica) o conjunta. Las actuaciones del sistema sanitario se referencian en el plan local, no se duplican.

Herramientas que se usan en la sesión

- Plantilla de priorización (CSV).
- Plantilla de plan de acción (CSV).
- Expediente del caso Zagra.

Planificar en promoción de la salud: por qué y cómo

SESIÓN 1 | Sesión presencial | 5 horas presenciales

- Objetivos de envejecimiento saludable de COMPÁS como referencia para la práctica 5.

Criterio de cierre

Cada grupo sale con una prioridad documentada (puntuación, deliberación y necesidades no priorizadas) y un primer esbozo de cadena hasta la actuación, que desarrollará en las actividades virtuales V1.

Caso de trabajo: Zagra, con datos del expediente territorial y sus fuentes. No incorporar datos personales ni información clínica individual en los trabajos.